EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90525
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-13 10:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN ANTONIO SAN MARTIN MENDEZ			RUN	: 5.216.467-2
F.Nac	: 15-12-1945	Edad	: 78 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-08	Fecha Egreso	: 2024-08-13 10:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) SDRA en vias de compensacion
2) AKI sobre ERC IIIb resuelta
3) HiperK 2°resuelta
4) EPOC sobreinfectado
5) IC en vias de compensacion (FEVI < 30%)
6) FA en TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU HSC el 08/08 por cuadro De Tos Productiva, Dineas, Cefalea, Inapetencia De 4 Días De Evolución. Sin Fiebre
Ingresa Consciente, Ventilando Espontaneo, Saturando 85% Ambiental, Fr 24 X Min, Normocárdico, Hipertenso. Se Apoya Con O2 X Naricera C Fio2 32%. , Piel Pálida, Yugulares Planas, Tórax Simétrico, Con Leve Uso De Musculatura Accesoria, Abdomen Bdi, Eess Y Eeii Edema (-).
Se Realiza Exámenes De Laboratorio Destaca: Crea 3.6 Glicemia 142 Lactato 1,0 Pcr 280.3 Uremia 140 Na 139 K 5.6 Cl 107 Gb 17100 Seg 86% Inr 2.5 Ph 7.32 Pco2 40.8 Po2 104 Fio 2 20.9 . Rx De Torax Cardiomegalia Importante Infiltrado Intersticial Difuso Basal Derecho. Se Valora Y Se Decide Su Ingreso.

Durante estadia se inicia terapia ATB de amplio espectro, con abundante tos productiva, se pequisa hiperK la cual es corregida con medidas de shift, panel viral (-), con mejoria de parametros inflamatorios. Desde la esfera renal ingresa con AKI sobre ERC, la cual es corregida con volemizacion cauitelosa

Actualmente paciente HDN estable, afebril, sin dolor, sin requerimiento de O2 suplementario, con buena tolerancia a alimentacion VO, diuresis y deposiciones (+).

Examenes de lab -> crea 2,1; lactato 0,7; PCR 32,2; uremia 115; Gb 10,9; Hb/Hcto 11.6/35.8; plaq 312000; segment 94%; GSV pH 7,44; HCO3 31

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, sin uso de musculatura accesoria
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Paciente cursando su dia N° 5 hospitalizado, dia N° 5 de ceftriaxona, en condiciones de continuar tratamiento via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflcito
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto actual
3) Respiratorio/infeccioso: Actualmente cursando dia N° 6 de tratamiento con ceftriaxona, parametros inflamatorios bajos, se procedera a completar 7 dias de terapia con ceftriaxona via HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Regimen hiposódico a tolerancia
3. Omeprazol 20 mg al dia VO por 2 dias
4. Ceftriaxona 2 gr EV por dos dias mas
5. Quetiapina 25 mg dia vo por 2 dias
6. Metolazona 2.5 mg vo cada 12 hrs por 2 dias
7. Espironolactona 25 mg 1 vez al día por dos dias
8. Diltiazem 60 mg cada 8 hs por 2 dias
9. Acenocumarol Segun Esquema Taco vo
10. Amiodarona 200mg cada 24 hrs vo por 2 dias
11. Fluticasona/Salmeterol (250/25mcg) 4 puff inh cada 12 h
12. Ipratropio 4 puff inh cada 6 hrs
13. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 2 dias

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO